

ПЭТ-КТ исследование с контрастным усилением ФДГ
Второе медицинское мнение

Имя пациента: Жерлицына Анастасия

Дата рождения: 25/04/1976.

Причина направления: по всей видимости, речь идет о метастатической лейомиосаркоме матки. С/п химиотерапии.

Дата исследования: 11/04/2023.

Методика: исследование выполнено после внутривенной инъекции, без перорального приема контрастного вещества.

Сравнение с предыдущими исследованиями: КТ грудной клетки, брюшной полости и малого таза от 23/08/2022.

Описание наблюдений:

Голова и шея:

Голова исследована частично.

Как известно, оценка паренхимы головного мозга в рамках этого исследования ограничена. Насколько можно судить, без видимых патологий.

Определяется ассиметричное накопление контраста в области ротоглотки слева, по-видимому, по причине воспалительных изменений.

Без признаков гиперметаболической лимфаденопатии в области шеи.

Щитовидная железа: размеры в пределах нормы, текстура однородная, без патологического накопления контраста.

Грудная клетка:

Без патологического накопления контраста в паренхиме легких. В легких определяется несколько небольших узелков, например, в верхней доле правого легкого и в язычке. Изменений данных наблюдений нет, все они находятся за пределами разрешающей способности ПЭТ.

Без плевральных выпотов.

Определяется минимальный перикардальный выпот.

Без патологического накопления контраста в лимфоузлах средостения и ворот легких.

Без патологического накопления контраста в паренхиме молочных желез.

Без патологического накопления контраста в подмышечных лимфоузлах.

В правой подмышечной впадине наблюдается венозный катетер Port-A-Cath, его край в ВПВ.

Брюшная полость и малый таз:

Печень: определяется патологическое накопление контраста во многочисленных образованиях в обеих долях. Наиболее крупное из них занимает почти всю правую долю, его размеры слегка увеличились по сравнению с предыдущим исследованием. Все образования неоднородные, некоторых из них лобулярные, некоторые сливаются воедино. В крупных образованиях отмечается низкое накопление контраста в некротических компонентах и сильное накопление контраста в солидных. Например, крупное образование правой доли увеличилось с 16 x 11 x 15 (длина) см до 20 x 12 x 17 (длина) см. Образование купола печени увеличилось с 6 x 8 см до 7 x 10 см. Образование хвостатой доли увеличилось с 1,5 до 1,7 см, левой доли – с 6 x 4,5 до 8 x 6 см.

Между желудком и хвостом поджелудочной железы определяется образование с патологическим накоплением контраста, похожее на образования печени. Его размеры уменьшились с 4,7 x 6,5 x 7 (длина) см до 4,5 x 5,7 x 5,7 (длина) см. Его источник неясен, возможно, стенка желудка. Очевидная плоскость разделения между образованием и поджелудочной железой отсутствует. Образование касается левой почки.

Желчный пузырь: не увеличен. Внутривенечные желчные протоки расширены.

Селезенка: размеры в пределах нормы, без патологического накопления контраста.

Патологического накопления контраста в паренхиме поджелудочной железы не отмечалось.

Правый надпочечник: оттеснен печенью, без образований, без патологического накопления контраста.

Левый надпочечник: утолщен, без патологического накопления контраста, без изменений.

Почки: без гидронефроза или обызвествленных камней.

Без признаков гиперметаболической лимфаденопатии брюшной полости, забрюшинного пространства или малого таза.

Без патологического накопления контраста в паховых лимфоузлах.

Мочевой пузырь: без патологий.

Кишечные петли: без патологий, насколько можно судить.

Матка: неоднородные лобулярные образования, сливающиеся воедино. Общий размер в аксиальной плоскости составляет 6 x 10 см. Образование, расположенные более краниально, содержит обызвествления – картина схожа с предыдущим исследованием. В образованиях отмечается легкое накопление контраста.

Кроме того, в латеральном аспекте справа отмечается округлое образование с четкими границами, диаметром около 6 см, без накопления контраста, около 50 HU (венозная фаза). Возможно, это миома или геморрагическая киста яичника. Без значительных изменений размеров данных наблюдений.

Костная ткань:

Без очагового накопления контраста или деструктивных процессов в области сканирования.

Определяется несколько неравномерное накопление контраста в грудном отделе позвоночника.

Заключение:

Определяется сильное патологическое накопление контраста в обширном билобулярном поражении печени. По сравнению с предыдущим исследованием наблюдается легкое ухудшение.

Определяется сильное накопление контраста в образовании между хвостом поджелудочной железы и желудком (его источник неясен) – размеры слегка сократились. В образованиях матки определяется лишь легкое накопление ФДГ, их размеры не изменились.

Следует рассмотреть возможность дальнейшего обследования с выполнением гистологического исследования образцов образований.

Несколько мелких легочных узелков – без изменений.

Остальные наблюдения – как изложено выше.

С уважением,

Д-р Куликов Виктория

Специалист по ядерной медицине

№ лицензии: 84847

№ лицензии специалиста: 131252

19/04/2023